

성인 Daily Day 09 - 간수치 상승

검진 이상

MASLD/FIB-4

KCD R94.5

작성일 2026-07-05

오늘의 목표

AST/ALT, ALP/GGT, bilirubin 패턴을 나누고 지방간, 바이러스간염, 약물성, 담도질환을 단계적으로 평가한다. MASLD 의심 환자는 FIB-4로 섬유화 위험을 나눈다.

1. 첫 3분 Triage

당일 의뢰: 황달 + 의식 변화/출혈 경향, AST/ALT 1000 전후 이상, bilirubin 상승과 RUQ pain/발열, acetaminophen 과량, 임신 중 간수치 상승.

- 간세포 손상형(AST/ALT)인지 담즙정체형(ALP/GGT/bilirubin)인지 나눈다.
- 음주, 약/보충제, 대사위험, viral hepatitis 위험, 담도 증상을 묻는다.
- 지방간 의심이면 FIB-4로 의뢰 필요성을 판단한다.

2. 핵심 문진/PE

문진 5개	Physical exam
술, 새 약/한약/보충제, 황달/회색변/RUQ pain, 비만/당뇨/지질, B/C형간염 위험	공막황달, RUQ 압통, 간비대, 복수/부종, BMI/허리둘레, 만성간질환 소견

3. 검사 루틴

패턴	1차 검사	행동
AST/ALT 중심	repeat LFT, bilirubin, ALP/GGT, CBC/platelet, albumin, PT/INR 가능 시	중증도와 기능 확인.
MASLD 의심	HbA1c, lipid, FIB-4, 복부초음파	섬유화 위험 분류.
viral hepatitis	HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV	양성이면 활동성 평가/의뢰.
약물성	약/보충제 timeline, acetaminophen 사용량	의심 약 중단, 중증이면 의뢰.
담즙정체형	ALP/GGT, bilirubin, 복부초음파	담도확장/담석 확인.

4. FIB-4

FIB-4	해석	행동
<1.3	낮은 위험	의원 추적. 대사위험 높으면 1-2년 재평가.
1.3-2.67	중간 위험	VCTE/ELF 등 2차검사 또는 의뢰.
>2.67	높은 위험	간섬유화 고위험으로 의뢰.

FIB-4	해석	행동
65세 이상	cutoff 조정	2.0 이상부터 의미 있게 본다.

5. KCD / Follow-up

R94.5	간기능검사 이상 소견.
K76.0	지방간/MASLD 근거가 있을 때.
B18.x/K71.x/K80.x	만성간염, 약물성, 담도질환 근거가 있을 때.

- 경도 상승은 원인 제거 후 2-4주 재검.
- 3개월 이상 반복 상승이면 원인검사 확장, 6개월 이상 지속이면 의뢰 고려.
- ALT 정상화만 보고 fibrosis risk를 잊지 않는다.

6. 환자 설명 스크립트

간수치는 간세포 손상인지 담즙길 문제인지 간 기능 저하인지 나눠서 봐야 합니다.
건강보조제와 한약도 간에 부담이 될 수 있어 최근 3개월 안에 시작한 것은 모두 알려주셔야 합니다.
지방간에서 중요한 것은 지방 자체보다 간섬유화 위험입니다. FIB-4로 추적과 의뢰를 나누겠습니다.

7. 자가체크

1. 간세포 손상형과 담즙정체형은 어떻게 구분하나?
2. 즉시 의뢰해야 할 red flag는?
3. FIB-4 1.3-2.67이면 다음 단계는?
4. 약물성 간손상 문진 범주는?
5. ALT 정상화 후에도 다시 봐야 할 위험은?

참고 출처

AASLD NAFLD/MASLD Practice Guidance 2023; ACG Abnormal Liver Chemistries Guideline; AACE NAFLD Primary Care Guideline.